

普通风寒感冒，中医当风热来治，80岁老奶奶咳嗽整夜睡不着

原创 二羊 养阳医斋 2019年12月10日 11:06

首先，感谢陆续还有默默给我点赞和打赏的朋友。

我好久没写文字了，一方面是精力有限，一方面是“懒”，懒就是心里耍赖，赖就过去了。

但遇到这个病人，我不想赖了，因为他不是一个病人，而是一类病人。就因为一个普通的感冒，看中医还看惨了。

她是我们门诊的一位老病号，让人印象深刻，每次来看病都非常客气，慈祥，说话微笑，眼里都是带着笑。嘴里常挂着“杨医生，给你添麻烦了”，“又来麻烦你了”。

她是一位高龄老奶奶，这位老皮奶奶的让人印象深刻，看一次病，我就记住她了。

一方面，我从来没有遇到过这么客气的病人，另一方面，她总给人亲切的感觉，让我想起我的奶奶。再有她的姓氏也很少见。姓“皮”，顽皮的皮，皮包的皮。怪我没文化，少见多怪。还下意识的想到了“布拉德·皮特”，那个帅帅的美国明星。

皮奶奶，身形干瘦，头发几乎白了。

信奉佛教，多年吃素，也许是常年吃素，营养不够，体检有贫血，蛋白质偏低。经常头晕乏力、眠差、怕冷。这样来找我调理。她说吃豆子多了现在还有点痛风，想一起调一下。

考虑到她的体质为气血亏虚，肝肾不足。我给他用的十全大补汤，金匱肾气汤这类交替给她调。一个月吃那么一两个星期中药。慢慢的头晕乏力，关节痛都消失了，睡眠好转。

半个月前，因为突然降温感冒，身体痛不舒服，不想跑那么远，就近的社区医院找了一个中医看。开了小柴胡、抗病毒、蛇胆川贝这类的中成药，吃了三天，症状没有好转，反而，心悸，咳嗽厉害。

再去复诊，医生又开了中药，吃了咳嗽又加重，不停的吐白色泡沫痰，咳嗽不停，夜都不能睡觉，同时，心慌心悸厉害。

医生处方如下：

机场 居委社区卫生服务站

门诊病历

复诊 就诊时间：2019-11-28 10:46:59 就诊科室：社区中医一科

姓名： 性别：女 身份证号： 年龄：80岁

联系人： 电话：020

关系：本人

主诉：咳嗽1周

现病史：患者自述咳嗽咳痰，咽痒，无发热，无呼吸困难、无发冷寒战、无恶心呕吐，纳可，二便调，睡眠欠佳，今来就诊。

既往史：否。

过敏史：否认药物及食物过敏史。

查体：T:36.5℃，P76次/分，R:18次/分，BP:118/70mmHg

神清、精神好、呼吸平稳、唇红、唇周无发绀、咽充血、咽后壁淋巴滤泡增生，双侧扁桃腺不肿大、双肺呼吸音清、未闻及干湿啰音、律齐、无杂音、腹软不肝脾不大，舌淡苔白，脉浮数

辅检结果：

诊断：上呼吸道疾病；
咳嗽-风热

处置结果：

银花15克	连翘10克	桔梗10克	竹叶(淡竹叶)10克
淡豆豉10克	荆芥10克	牛蒡子10克	芦根10克
生甘草10克	麦冬10克	玄参10克	浙贝20克
鱼腥草10克	猫爪草15克	柴胡10克	白前15克
岗梅10克			

3付，水煎服，一日一剂，每天二次

穴位贴敷治疗 16(每个穴位) 中药封包治疗(大) 2(次)

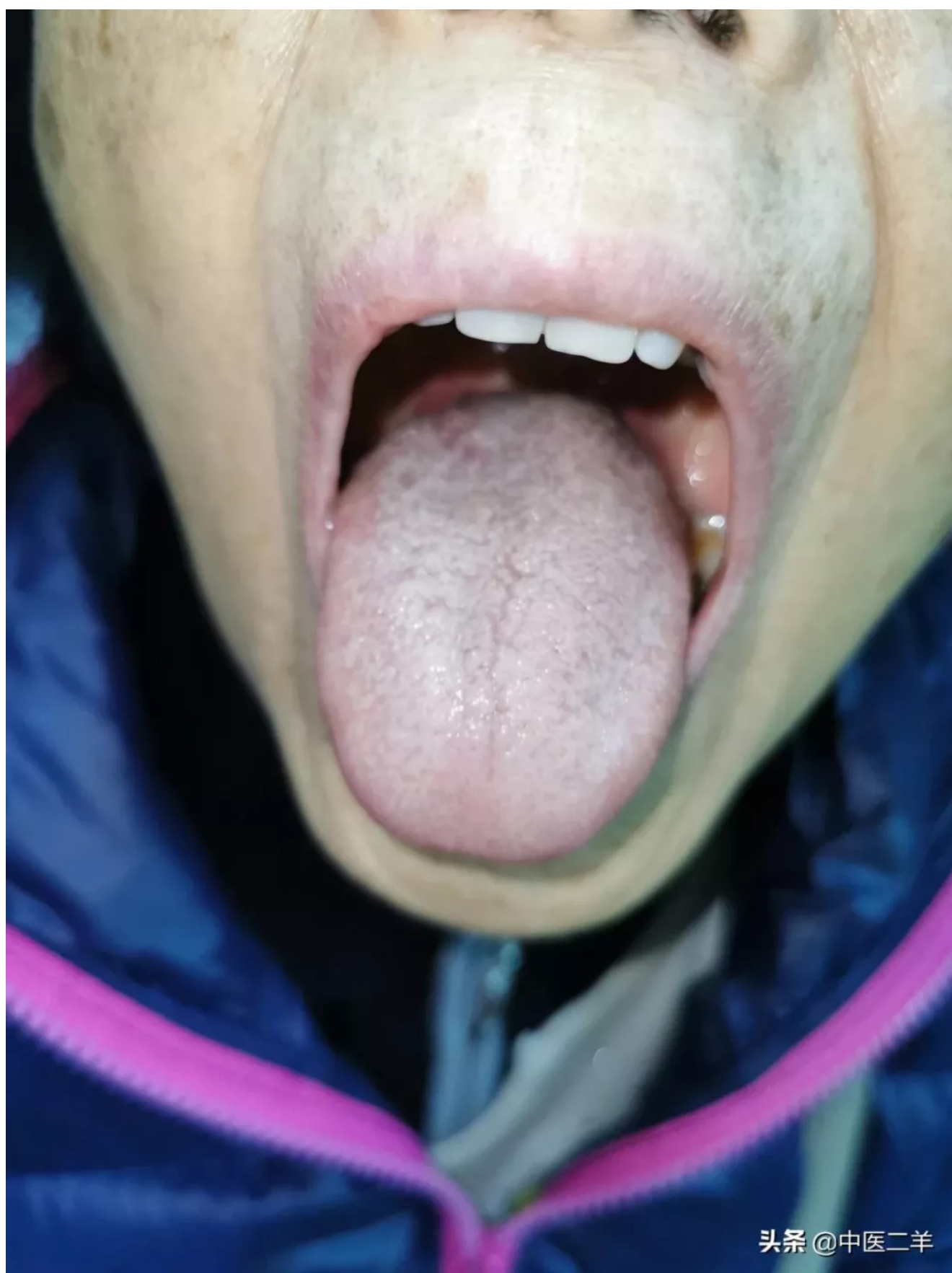
手指点穴(每增加一个穴加收) 20(一个穴位)

建议：清淡饮食，按时休息，不适随诊

头条 @中医二羊

这样折腾了一个星期，实在太难受了，才来找我。我一看舌头，舌淡苔白，再摸脉，脉浮缓无力。

这分明是体虚外感，是寒偏重，按风热来治，肯定会加重了。还用了穴位贴敷，按摩这类，简直是瞎整。



头条 @中医二羊

好脾气的我，有一点生气了。

一个80岁的老人家，平时又体虚，这一折腾，老人家肯定难受。

皮奶奶吃了这些药，心悸厉害。这分明就是寒凉药伤了心阳，寒症当热病来治，咳嗽不加重才怪。

伤寒论有条文这样说：

“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤”

这个医生开的寒凉清热药，虽然不是发汗过度，但结果都一样，伤了心阳引起水气凌心，引发心悸。

方向完全相反了，南辕北辙。

平时我也比较熟悉这个病号，偏阳虚、气血不足。接下来，开了偏温的药，用了一个星期把她的情况慢慢扭转过来。用的是张仲景的经方小青龙汤加减

(R05.x00)咳嗽			
	开始时间	内容	总量 单位
☐	2019-12-05	普通门诊诊查费	1 次
☐	2019-12-05 15:51	中药3付,每天一剂,自煎,水煎服:桂枝 15g,白芍 10g,细辛(5克/包) 5g,五味子 15g,干姜 15g,防风(15克/包) 15g,蜜麻黄(炙麻黄) 10g,炙甘草 9g,紫苏子 15g,前胡 15g,苦杏仁(燀) 10g,茯苓(15克/包) 15g,紫菀 10g,款冬花 15g,肉桂 10g	3 付

具体用药，仅供参考，请勿套用。药方缺半夏，方子里没有半夏。

我想起咱们老祖宗的一句话，“有病不治，常得中医”，说的是有病不去治，就相当于得到一个中等水平的医生治疗。

很尴尬，我们一边提倡中医，普及中医，但是目前中医行业的水平令人堪忧，老百姓去看了中医又得不到正确的医治。这样日子久了，中医自然失去信任。

其实，看好感冒本来就是中医的基本要求，中医的本分。但是中医研究生毕业很多都不会治感冒，一些社区中医沦为开药机器。基本的寒热不辨，阴阳不分。

目前看中医就只能高价去找那些“名老中医了”，关键名老又不全是“有效”，真是很无奈。

大家想学中医，想看中医，找不到门径，找不到好中医。同行本不应该相轻，但是，很无奈。这个案例也鞭策和告戒自己，不要做“那样的中医”。临床复杂多变，我们并不能每次都辨证准确，用方精准，但是基本底线，基本的要求还是要尽量做到，这样不至于害了人。

我有点生气，按耐不住要写下来，因为这样的案例不是极个别，是一类的病人。感冒去看中医，中医们一看到咽喉痛就用清热解毒的方法，于是，我就遇到好几个皮奶奶这样的病人。吃了中药不仅没好还增加其他的病症或者遗留其他的病症。

银翘散/桑菊饮其实是很好的方子，温病派也不是不好，只是现代人学中医没能很好的继承罢了。

其实，现代人的思维都这样，或者现代中医受西医影响太深，咽喉痛就是炎症，就要消炎，吃抗生素打点滴。中医就是风热，中药就要清热解毒、银翘散这些就上了。中药当消炎药一样的滥用，套用。

于是，越来越多的慢性呼吸道病。慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎.....医生们把急性病治成了慢性病，还说这个病不能好的，只能控制。

最近，一个慢性反复咳嗽中年大叔，被诊断为慢性支气管炎，反复咳嗽，遇冷加重。吃了两周中药既然好了。他本人很意外，自然也增加了我对中医中药的信心，尤其是伤寒论的经方。当然，慢性病的因素很多，并不是每个人都那么好彩，都那么好治。

中医好，并不代表你看的中医好。针灸能治病，但并不代表给你做针灸的医生能治病。

看中医，进入了一个看人的时代，看缘分时代。哀呼？

另外，中医票友会问怎么区分风寒和风热？

在我的眼里没有风寒和风热之分，只有随证治之。疾病是动态的、发展的，人是活的，看病的人更应该是活的。

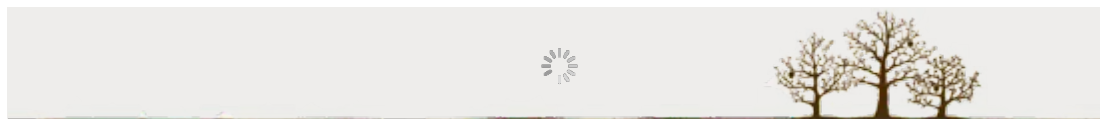
刻舟求剑的方法本身就不对，不是在哪里“标记”能找到剑的问题。

当然，我的回答不能满足你的需求。所以还是告诉你教科书的方法：

仅提供给考试做题参考；

	风 寒	风 热
寒热	恶寒重、发热轻	发热重,恶寒轻
汗	无汗	有汗
鼻流涕	鼻流清涕	鼻流浊涕
咽	咽痒	咽痛
渴	口不渴	口渴
舌苔薄	舌苔薄白	舌苔薄黄
脉浮	脉浮紧	脉浮数

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。

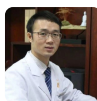


如果对你有帮助，欢迎分享

中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色梔子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

👍 喜欢作者

医案分享：中医的道与术 · 目录

◀ 上一篇

同一个人，同样感冒，两个不同相反的方子，病却都好了

下一篇 ▶

病毒肺炎特殊时期，我顶风看了一例特殊发烧者